



TROUBLES RESPIRATOIRES OBSTRUCTIFS DU SOMMEIL (TROS)

Pr Oudidi / Pr Afellah

28/11/2025

Plan

- INTRODUCTION
- DEFINITIONS
- DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES
- PHYSIOPATHOLOGIE
- DIAGNOSTIC POSITIF : TDD : SAHOS
- FORMES CLINIQUES
- PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE
- CONCLUSION

INTRODUCTION

- Augmentation anormale des résistances des Voies Aériennes Supérieures (VAS) pendant le sommeil ,
- Allant du Ronflement simple (RS) au syndrome d'apnées obstructive du sommeil (SAOS) .
- Les troubles respiratoires obstructifs du sommeil (TROS) sont les plus fréquents des troubles du sommeil.
- Incidence élevée avec une Morbidité – Mortalité.

INTRODUCTION

- Progrès: Diagnostique et thérapeutique
- Prise en charge multidisciplinaire : ORL, Pneumologue, Cardiologue, Nutritionniste..
- Le rôle de l'ORL est primordial dans le dépistage, l'exploration et le traitement des anomalies anatomiques en cause.

QUELQUES DEFINITIONS

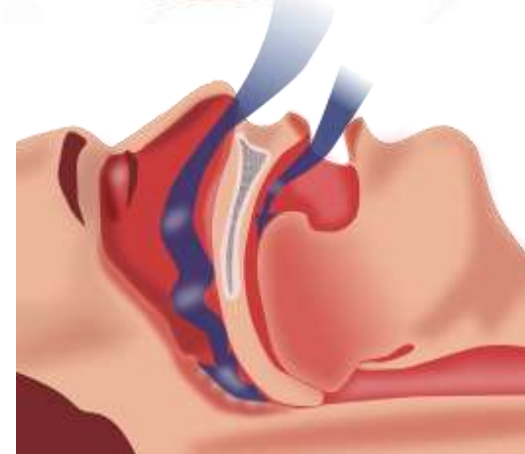
Ronflement:

- **Bruit** inspiratoire au cours du sommeil.



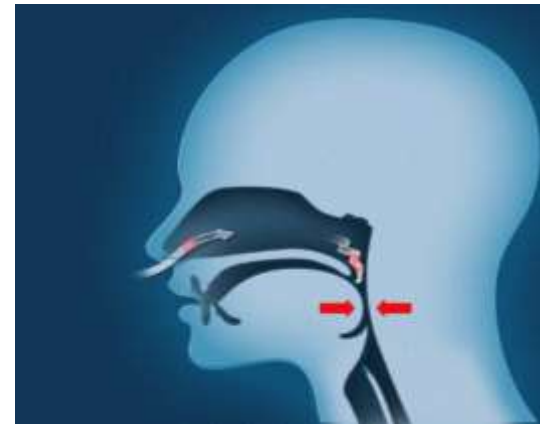
Apnée :

- **Arrêt** du débit aérien naso-buccal pendant au moins 10 secondes.



Hypopnée :

- **Diminution** du débit aérien naso-buccal pendant au moins 10 secondes.



INTERET DE LA QUESTION

- Pathologie souvent méconnue
- Pourtant fréquente
- Complications (SAHOS) :
 - cardiaques
 - métaboliques
 - Neurologiques
 - Somnolence diurne
- Conséquences socio-psychologiques

Problème de santé
publique++



DONNEES EPIDEMIOLOGIQUE

- Ronflement : > 30% de la population
- Le syndrome d 'apnée du sommeil :
 - 4% de la population masculine
 - 2% de la population féminine
 - la fréquence augmente avec l'âge .
 - Chez l'enfant : 3 % des enfants d'âge préscolaire.

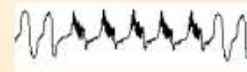
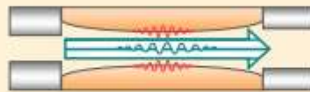
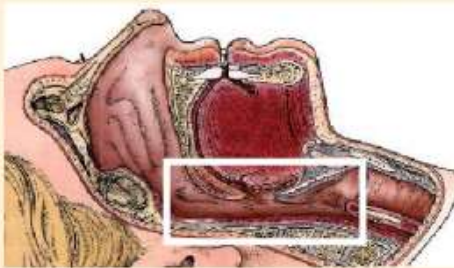


PHYSIOPATHOLOGIE

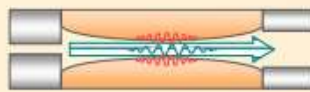
TROUBLES RESPIRATOIRES OBSTRUCTIFS DU SOMMEIL (TROS)



Respiration normale



Limitation de débit



Hypopnée



Apnée

↘ Force musculaire pharyngée

↗ Compliance des parois musculaires

Instabilité du contrôle central

**Collapsus
pharyngé**

Obstacle anatomique

Apnée / hypopnée

Hypoxémie

Stimulation chémorécepteurs carotidiens +
Mécanorécepteurs pulmonaires et pharyngés

Complications cognitives

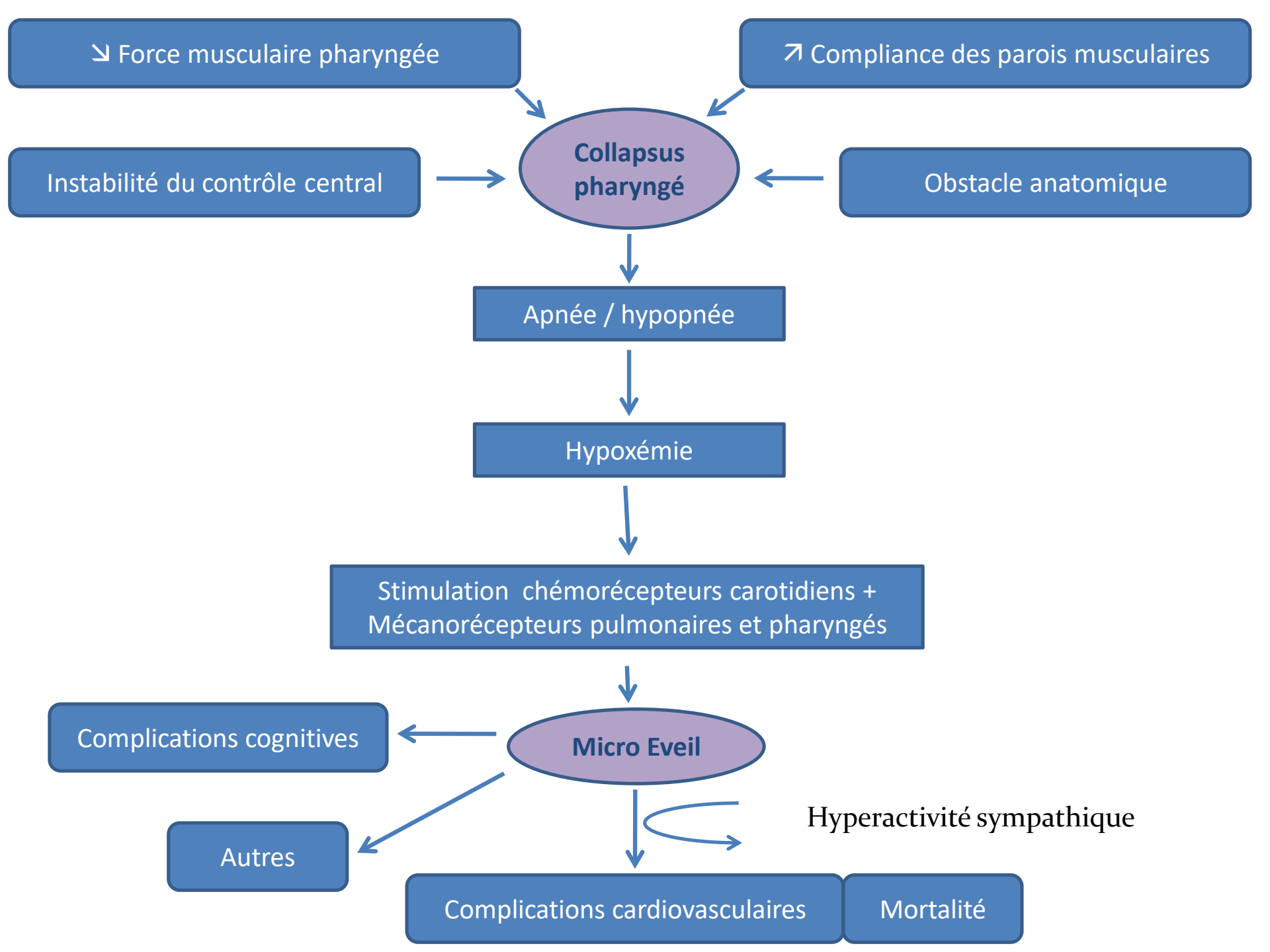
Micro Eveil

Autres

Hyperactivité sympathique

Complications cardiovasculaires

Mortalité





DIAGNOSTIC POSITIF

TDD : SAHOS de l'adulte

DIAGNOSTIC POSITIF

I. Interrogatoire

– Patient :

- ▶ Etat civile
- ▶ ATCD : Cardio-Vasculaires, ORL, habitudes toxiques
- ▶ Symptômes diurnes et nocturnes

– Conjoint ++: présence de

- ▶ Ronflement
- ▶ Apnées
- ▶ Irritabilité
- ▶ Les mesures d'évitement (chambre à part , les embouts anti bruit)



INTERROGATOIRE

1. Symptômes nocturnes :

- ▶ Ronflements (présent dans 95% des cas)
- ▶ Pausés respiratoires au cours du sommeil constatées par l'entourage
- ▶ Sensations d'étouffement ou de suffocation pendant le sommeil
- ▶ Polyurie nocturne (nycturie)



INTERROGATOIRE

2. Symptômes diurnes :

- ▶ Somnolence diurne excessive (SDE)
- ▶ Asthénie
- ▶ Troubles cognitifs à type de troubles mnésiques ou de la concentration
- ▶ Troubles de la libido
- ▶ Céphalées matinales



Des maux de tête matinaux
ont été signalés chez

18,9 % des patients souffrant
d'apnée sommeil

&

16,2 % des ronfleurs



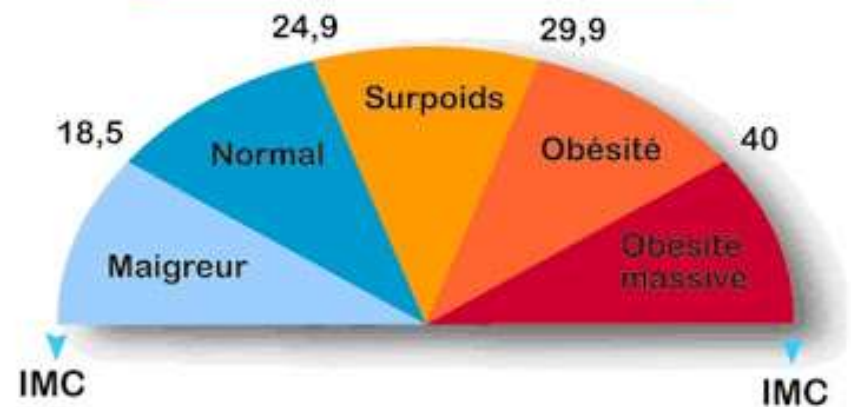
EXAMEN CLINIQUE

1. Examen général :

- ▶ Etat général du patient
- ▶ Poids et taille : IMC
($>30 \text{ Kg/m}^2$ = obésité),
Circonférence abdominale .
- ▶ Constantes
hémodynamiques : TA
+++

IMC = Indice de Masse Corporelle

$$\text{IMC} = \frac{\text{poids en kilos}}{(\text{Taille X Taille}) \text{ en mètres}}$$



2. Examen oto-rhino-laryngologique :

- ▶ **Examen de la cavité buccale et de l'oropharynx**
- ▶ **Examen des fosses nasales**
- ▶ **Examen pharyngo-laryngé**
- ▶ **Examen du morphotype cervico-facial**

a. Examen de la cavité buccale et de l'oropharynx :

- ▶ Anomalie de de l'articulé dentaire :
Rétrognatisme , Rétromaxillie
- ▶ Macroglossie .
- ▶ Hypertrophie amygdalienne
- ▶ Palais ogival , Allongement de la luvette.



b. Examen des fosses nasales :

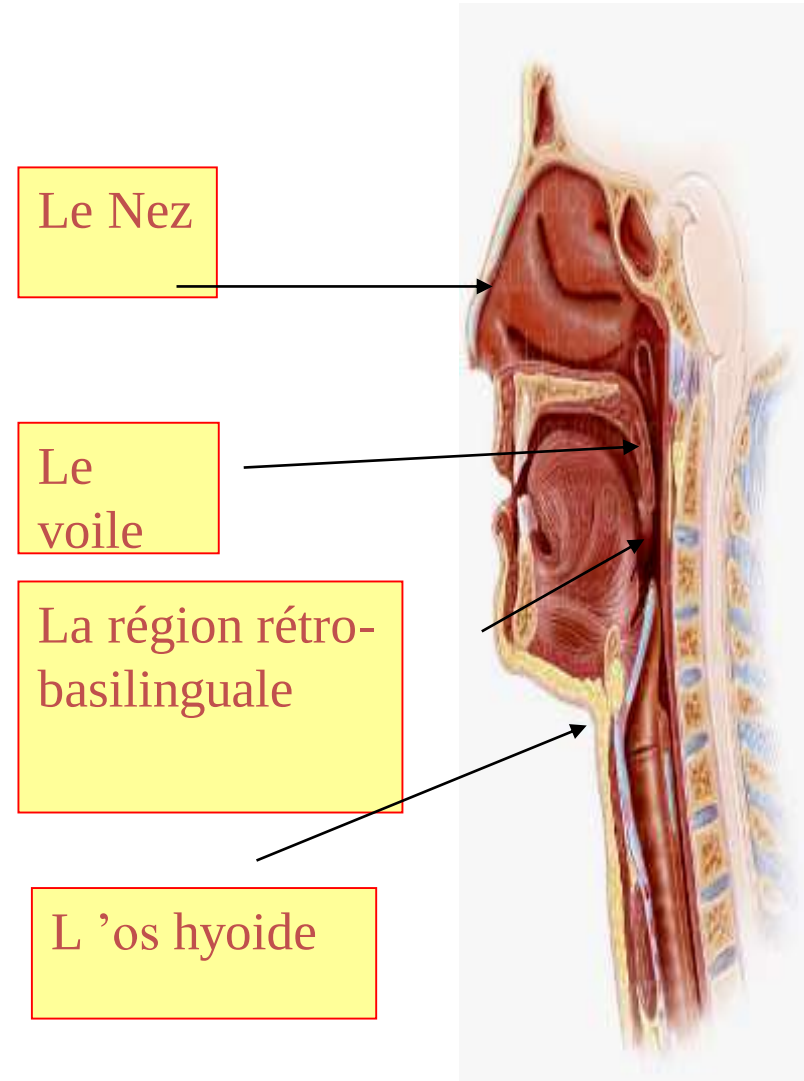
- La rhinoscopie antérieure, ou mieux **la nasofibroscopie** recherche :
 - une valve nasale étroite
 - une déviation septale
 - une hypertrophie des cornets inférieurs
 - une hyperplasie adénoïde.
 - Pathologie inflammatoire ou Tumorale



c. Examen pharyngolaryngé :

Nasofibroscopie++ :

- Confirme la cause de l'obstruction nasale
- Analyse la région rétro-basilinguale , rétrovélaire
- Propulsion mandibulaire et linguale : ouverture de l'espace rétro basilingual .



d. Examen de morphologie cervico-facial:

- Dysmorphose faciale hyperdivergente (visage allongé, mandibule basse, angle facial ouvert) ;
- Cou court
- Ouverture de l'angle thyromental due à la verticalisation du plancher buccal et à la chute de l'os hyoïde.
- Surcharge adipeuse cervicofaciale
- Mesure du périmètre cervical ++



Le reste de l'examen clinique :

- Cardio-vasculaire : +++
 - TA
 - Fréquence et rythme cardiaques ...
- Pleuro-pulmonaire :
 - Le syndrome obésité-hypoventilation (SOH)

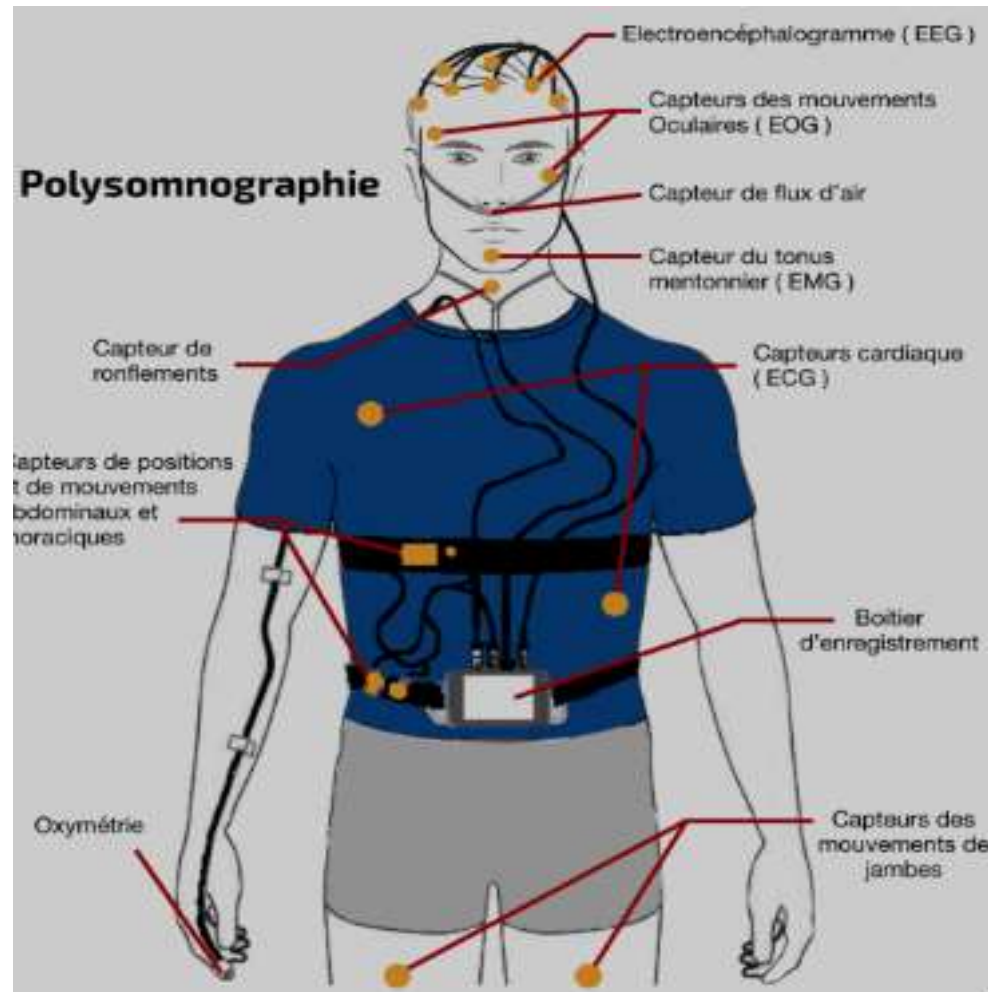


EXAMENS PARACLINIQUES

1. Polysomnographie :

Mesure les paramètres nécessaires au **scorage** du sommeil:

- EEG (activité cérébrale)
- Électro-oculogramme (EOG)
- Électromyogramme (EMG) du menton
- EMG des jambiers antérieurs



EXAMENS PARACLINIQUES

2. Polygraphie ventilatoire

3. Autres explorations :

- Imagerie du massif facial et du pharynx:
Céphalométrie, Panoramique dentaire , La tomodensitométrie et l'IRM
- Examens biologiques : bilan métabolique

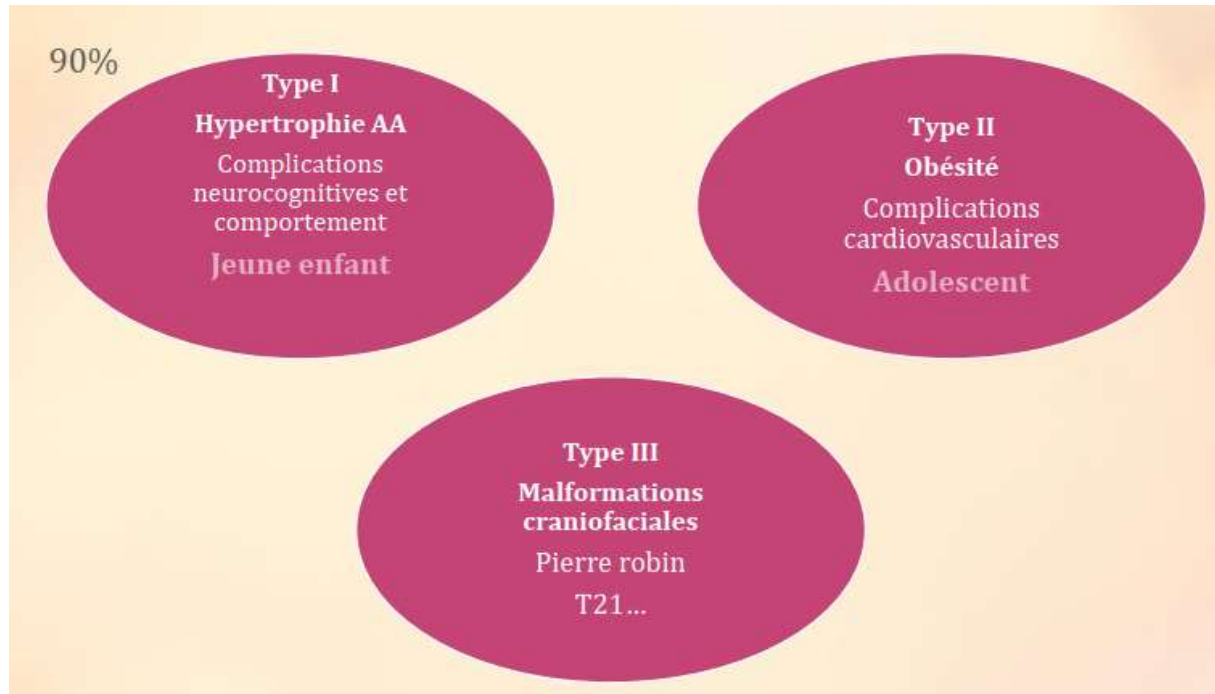
FORMES CLINIQUES

1. RONFLEMENT SIMPLE :

- Bruit inspiratoire au cours du sommeil
- Sans événements obstructifs (Absence d'apnées et des hypopnées)
- Gêne sociale et/ou pour le conjoint.

2. FORMES CLINIQUES CHEZ L' ENFANT

- 3% entre 3 et 8 ans



TROS TYPE I



TROS type II

TROS TYPE III



PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE

A. Buts:

- Améliorer la qualité du sommeil .
- Améliorer les signes diurnes et nocturnes.
- Eviter la survenue des complications .

B . Moyens :

a. Médicaux :

- **Mesures hygiéno-diététiques (MHD)++:**
 - Réduction pondérale
 - Activité physique
 - Sevrage du tabac + alcool
 - Arrêt de sédatifs
- Traitement postural
- Traitement de pathologies associées

B . Moyens

- **b. Traitement chirurgical :**
 - Amygdalectomie
 - La chirurgie de la valve nasale
 - La chirurgie septo-turbinale
 - Uvulopalatopharyngoplastie (UPPP)
 - Ostéotomie d'avancée bi-maxillaire
 - Chirurgie bariatrique
 - Stimulation du nerf hypoglosse

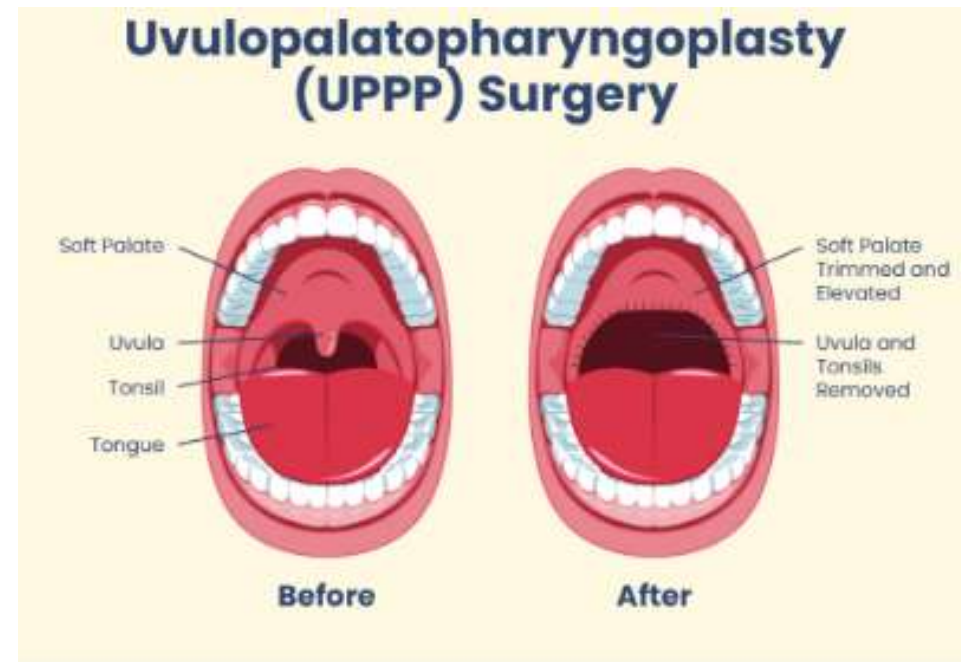
Moyens Médicaux

Traitement postural



TRAITEMENT CHIRURGICAL

- UPPP
- **Principe :**
diminuer la hauteur du voile, élargir le pharynx



B . Moyens

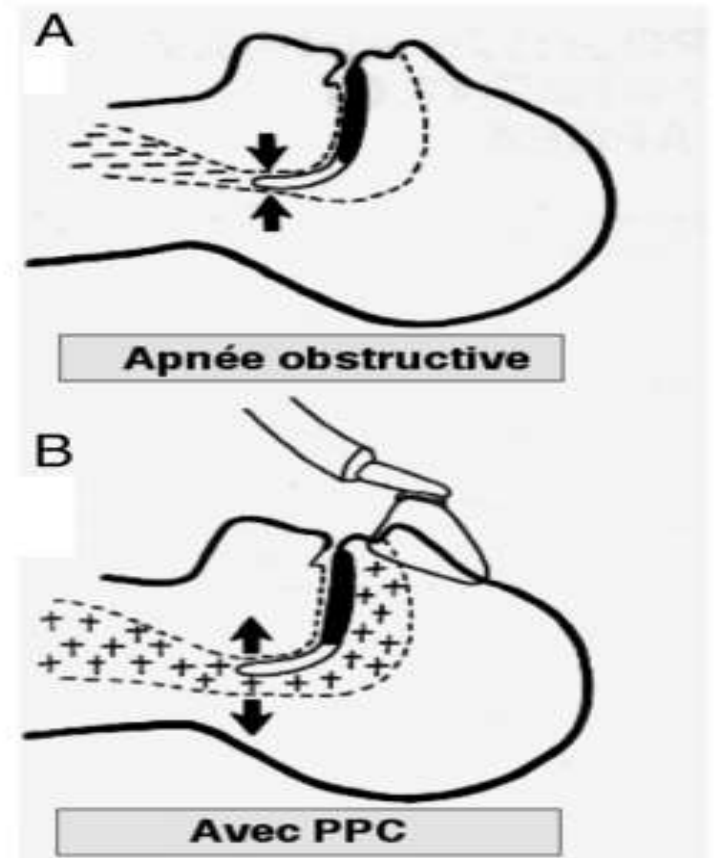
c. Traitements prothétiques:

- Ventilation à pression positive continue (PPC)
- Orthèses d'avancé mandibulaire(OAM)
- Prothèses dilatatrices nasales



PPC

- Elle permet de maintenir les voies aériennes supérieures ouvertes pendant le sommeil, supprimant ainsi les apnées et les hypopnées .
- Nécessite une éducation thérapeutique et suivi d'observance .



INDICATIONS THERAPEUTIQUES

- Les mesures hygiéno-diététiques (MHD) sont toujours indiquées ++
- La Chirurgie ORL : si obstacle local (amygdales hypertrophiques , Déviation septale ..).
- Si échec : Moyens prothétiques (PPC , OAM)

CONCLUSION

- Problème de santé publique
- Déceler et traiter un SAHOS ++
- Information loyale et claire du patient :
 - Ronflement simple : Traitement « **de confort** »
 - SAOS : Traitement « **indispensable** »
- Large arsenal thérapeutique
- La **prise en charge** est **multidisciplinaire**



What Is Sleep Apnea_.mp4



endoscopie de sommeil.mp4



**Collapsus antéro -
postérieur partiel**



**Collapsus antéro –
postérieur complet**

***"Le traitement des apnées du sommeil donne
des années à la vie et de la vie aux années "***



Merci de votre attention